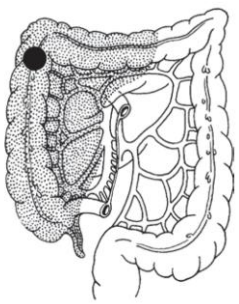
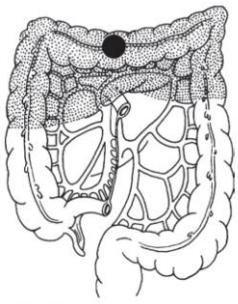
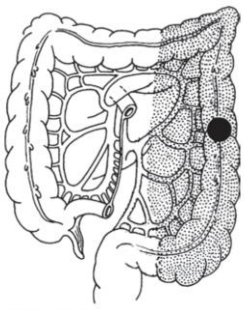

图 41-15 右半结肠切除范围


图 41-16 横结肠切除范围


图 41-17 左半结肠切除范围


图 41-18 乙状结肠切除范围

三、直肠癌（最常见）

1.多有梗阻（大便细）、便血、里急后重、肛门下坠感 溃疡性结肠炎:好发于直肠(里急后重)和乙状结肠
直肠细 刺激到直肠

2.**肛门外括约肌和肛提肌** 10版

Dixon 低高
直肠癌:1-2
乳腺癌保乳:1-2

①受累：腹会阴切除 Miles 术（不保肛）mei 肛门

②**未受累：即使低位也可结肠-直肠低位吻合（Dixon 术，切缘≥1cm）**、或结肠-肛管超低位吻合（Parks/括约肌间切除 ISR 术）。行临时性回肠造口以减少吻合口漏（远近都可以打滴滴）

不论肿瘤的直径
3.根据病灶下缘距肛缘/齿状线的距离 9版

①腹膜返折以下/距肛缘＜7/距齿状线＜5cm：Miles 术（不保肛）
méi

②腹膜返折以上/距肛缘≥7/距齿状线≥5cm：Dixon 术（切缘≥2cm）儿子二奶
关注等号:能保肛尽量保肛



注意：直肠、乙状结肠交界处按直肠癌处理

4.**Hartmann 术**（经腹直肠癌切除+近端造口/人工肛门+远端封闭肛门）

①**急性肠梗阻不宜行 Dixon 术**（本该做 Dixon 但急性肠梗阻一期吻合不上）

②不耐受 Miles 术（本该做 Miles 但现在不耐受不敢再切肛门）

